MATERNITY NURSING

Antenatal *Care*

Comprehensive Academic Summary Covering Gravidity & Parity, Importance of ANC, Traditional and WHO Focused ANC Models, Booking Visit History, Naegele's Rule, Physical & Abdominal Examination, Weight Gain, Laboratory Tests, Warning Signs and Teaching Advice.

Lecture Summary · **Antenatal Care**

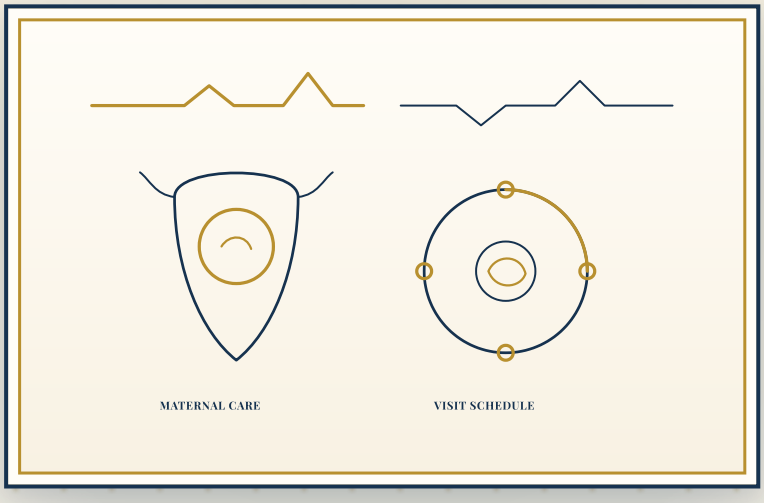


PLATE I — *Care across the trimesters: from the booking visit to the 36–38 week check.*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

💡 **نصيحة:** ابدأ بـ **بسم الله**، وصلِّ على النبي ﷺ، واجعل نيتك **خدمة المرضى** — فالتمريض عبادة إذا صحت النية وحسُن الأداء.

Introduction & Terms Related to Pregnancy

Introduction: Antenatal care (ANC) is the care provided by skilled health-care professionals to pregnant women to ensure the best health conditions for both mother and baby. ANC reduces maternal and perinatal morbidity and mortality **directly** (detection and treatment of pregnancy-related complications) and **indirectly** (identifying women at increased risk of complications during labor and delivery, ensuring referral to an appropriate level of care).

المقدمة:

• رعاية الحمل يقدمها مختصون مؤهلون لضمان أفضل صحة للأم والجنين، وتقلل المراضة والوفيات بطريقة مباشرة (اكتشاف المضاعفات وعلاجها) وغير مباشرة (تحديد السيدات المعرضات للخطر أثناء الولادة وتحويلهن للمستوى المناسب).

Gravidity & Parity

A. GRAVIDITY

— **Gravida:** a pregnant woman
— **Gravidity:** the number of pregnancies
— **Nulligravida:** never been pregnant
— **Primigravida:** pregnant for the first time
— **Multigravida:** pregnant more than once

B. PARITY

— **Parity:** number of deliveries reaching viability (not number of fetuses, e.g., twins) past **24 weeks**, alive or not
— **Viability:** capability to survive outside the uterus (≈ **24 weeks**)
— **Nullipara:** no delivery reaching viability
— **Primipara:** 1 birth reaching viability
— **Multipara:** 2 or more births
— **Grand multipara: 5 or more** births past viability

عدد مرات الحمل والولادة:

• **عدد مرات الحمل (Gravidity):** لم تحمل أبدًا (Nulligravida)، وحامل لأول مرة (Primigravida)، وحملت أكثر من مرة (Multigravida).
• **عدد الولادات (Parity):** عدد الولادات التي بلغت سن الحياة (بعد 24 أسبوعًا) سواء وُلد الجنين حيًّا أم لا، ولا يُحسب بعدد الأجنة؛ فالتوائم تُحسب ولادة واحدة.
• **سن الحياة (Viability):** قدرة الجنين على العيش خارج الرحم، نحو 24 أسبوعًا.
• لم تلد (Nullipara)، وولدت مرة (Primipara)، وولدت مرتين فأكثر (Multipara)، وولدت خمس مرات فأكثر (Grand multipara).

Definition & Importance of ANC

— An **umbrella term** for medical care and procedures carried out to and for the pregnant woman throughout pregnancy until the child's birth — the medical and nursing supervision and care given between **conception and the onset of labor**.

— 1. Reduce maternal and perinatal mortality and morbidity.

— 2. Improve physical and mental health of women for better outcome.

— 3. Prepare the woman for labor, lactation and infant care.

— 4. Detect early and treat complications endangering mother or fetus.

تعريف رعاية الحمل وأهميتها:

• مصطلح شامل للرعاية الطبية والتمريضية والإشراف المقدَّم للحامل من الإخصاب حتى بدء الولادة.
• تهدف إلى خفض وفيات ومراضة الأمهات والمواليد، وتحسين صحة المرأة الجسدية والنفسية، وإعدادها للولادة والرضاعة ورعاية طفلها، واكتشاف المضاعفات مبكرًا وعلاجها.

Schedule of ANC Visits — Traditional Model & Booking Visit History

RISK	FREQUENCY OF VISITS (TRADITIONAL MODEL)
Low-risk	Every **month till 28 weeks** → every **2 weeks till 36 weeks** → **weekly** till the end of pregnancy
High-risk	Every **2 weeks till 28 weeks** → **weekly till 36 weeks** → hospitalization or according to condition

The traditional model includes 2 visit types: **1. Booking visit (1st visit)** — complete history, physical examination, laboratory examinations; and **2. Subsequent (ongoing) visits**.

النموذج التقليدي للزيارات:
- **منخفضة الخطورة:** زيارة شهرية حتى الأسبوع 28، ثم كل أسبوعين حتى الأسبوع 36، ثم أسبوعيًا حتى نهاية الحمل.
- **عالية الخطورة:** كل أسبوعين حتى الأسبوع 28، ثم أسبوعيًا حتى الأسبوع 36، ثم دخول المستشفى أو حسب الحالة.
- يتكون من زيارة الحجز الأولى (تاريخ مرضي كامل، وفحص جسدي، وتحاليل) والزيارات اللاحقة المتابعة.

Booking Visit — Complete History Taking

HISTORY	CONTENT
A. Personal & social	Code, age, occupation, residence, years of marriage, phone; barriers to care; communication obstacles; planned pregnancy or not; nutritional status; unstable marital relation; mental health (anxiety, stress); smoking, alcohol, drugs — **smoking → IUGR**; **alcohol → IUGR + congenital malformations**
B. Family	Medical, genetic or congenital anomalies: DM, hypertension, heart disease, cancer, anemia, others
C. Medical & surgical	Some conditions worsen in pregnancy (heart valve disease → cardiac failure; hypertensive → high risk of pre-eclampsia). Medical: DM, anemia, HTN, renal disease. Surgical: CS, appendectomy, cholecystectomy, blood transfusion
D. Previous obstetric	Full-term, para, abortion, living children — OB digit (**TPAL**; GP = total pregnancies and parity); birth weight & weeks; mode and location of delivery; maternal or newborn complications
E. Present	First day of LMP; regularity, duration, frequency of cycle; contraception; planned or not; EDD

Naegele's Rule: 1st day of LMP **+ 7 days**, **+ 9 or − 3 months**, and add one year (when subtracting 3 months).
Example: LMP 14/6/2024 → +7 days, −3 months, +1 year → **EDD = 21/3/2025**.

التاريخ المرضي في زيارة الحجز:
- **الشخصي والاجتماعي:** البيانات الأساسية، وعوائق الرعاية والتواصل، والتخطيط للحمل، والتغذية، واستقرار العلاقة الزوجية، والصحة النفسية، والتدخين (يسبب تأخر نمو الجنين) والكحول (يسبب تأخر النمو والتشوهات الخلقية).
- **العائلي:** السكري، وضغط الدم، وأمراض القلب، والسرطان، والأنيميا، والأمراض الوراثية والتشوهات.
- **الطبي والجراحي:** بعض الأمراض تسوء مع الحمل؛ فريضة الصمامات قد تصاب بفشل القلب، ومريضة الضغط معرضة لتسمم الحمل؛ مع سؤال عن الولادة القيصرية والعمليات ونقل الدم.
- **الولادات السابقة:** عدد الحمل والولادات والإجهاض والأطفال الأحياء (TPAL)، ووزن المواليد، وطريقة الولادة، والمضاعفات.
- **الحالي:** أول يوم من آخر طمث، وانتظام الدورة، ووسيلة منع الحمل.
- **قاعدة نيجل:** أول يوم من آخر طمث + 7 أيام − 3 أشهر + سنة؛ مثال: 14/6/2024 يصبح موعد الولادة 21/3/2025.

Warning Signs During Pregnancy (call the physician immediately)

- Vaginal bleeding
- Abdominal pain
- Severe persistent headache
- Sudden gush of fluid
- Sudden stop of fetal movement
- Persistent vomiting
- Severe lower limb edema
- Chills and fever or pain on urination

علامات الخطر أثناء الحمل:
- النزيف المهبلي، وألم البطن، والصداع الشديد المستمر، ونزول سائل مفاجئ، وتوقف حركة الجنين فجأة.
- القيء المستمر، والتورم الشديد في الساقين، والقشعريرة والحمى أو الألم أثناء التبول، وكلها تستدعي الاتصال بالطبيب فورًا.

Booking Visit — Physical Examination

Purpose: to detect previously undiagnosed physical problems and to establish baseline levels.

SYSTEM	ASSESSMENT
GIT	**Mouth:** gums may be red, tender and edematous (↑ estrogen). **Intestine:** bowel sounds; constipation or diarrhea; hemorrhoids
Neck	Thyroid enlarges slightly in the **2nd trimester**; gross enlargement or tenderness may indicate hyperthyroidism

SYSTEM	ASSESSMENT
Cardiovascular	Assess DVT and edema. Heart: murmur, supine hypotension and/or palpitations — may be normal but requires evaluation; educate on positioning
Lungs	Dyspnea in 3rd trimester, ↑ RR — educate about normal discomforts
Back	Backache, scoliosis — discuss posture; consider anesthesia consult for planned epidural
Rectum	Hemorrhoids — education; over-the-counter hemorrhoid remedies
Vital signs	Blood pressure, pulse, respiration, temperature
Skin	Chloasma, linea nigra, striae gravidarum; nail beds pink with instant capillary return; pallor may indicate anemia
Breasts	Size, symmetry, nipple condition, presence of colostrum

الفحص الجسدي في زيارة الحجز:
- يهدف لاكتشاف مشكلات غير مشخصة وتحديد القيم الأساسية.
- **الجهاز الهضمي:** احمرار اللثة وتورمها بسبب الإستروجين، وأصوات الأمعاء، والإمساك أو الإسهال، والبواسير.
- **الرقبة:** تضخم الغدة الدرقية قليلاً في الثلث الثاني، والتضخم الكبير أو الإيلام قد يدل على فرط نشاطها.
- **القلب والأوعية:** فحص التجلط الوريدي العميق والتورم، والنفخة القلبية وهبوط الضغط في وضع الاستلقاء والخفقان قد تكون طبيعية لكنها تحتاج تقييمًا؛ **والرئتان:** ضيق التنفس في الثلث الأخير.
- **الظهر:** آلام الظهر والجنف؛ **والمستقيم:** البواسير، مع قياس العلامات الحيوية.
- **الجلد:** الكلف، والخط الأسمر، وتشققات الحمل، وشحوب الجلد الدال على الأنيميا؛ **والثدي:** الحجم والتماثل والحلمة ووجود اللبأ.

Weight Gain During Pregnancy

DISTRIBUTION OF WEIGHT GAIN

- Maternal stores of nutrients & muscle: **3 kg**
- Increased body fluid: **2 kg**
- Increased blood volume: **1.5–2 kg**
- Enlarged uterus: **1 kg**
- Placenta: **600 g**
- Baby: **2.5–4 kg**
- Breast growth: **600–1,300 g**
- Amniotic fluid: **1 kg**

WEIGHT GAIN BY PRE-PREGNANCY BMI

- BMI < 18.5 → **12–18 kg**
- BMI 18.5–24.9 → **11.5–16 kg**
- BMI 25–29.9 → **7–11.5 kg**
- BMI ≥ 30 → **5–9 kg**
- **By trimester:** 0.5–1.5 kg (1st) · 1.5–4 kg (2nd) · 4–6 kg (3rd)

زيادة الوزن أثناء الحمل:
- **توزيعها:** مخزون الأم من الغذاء والعضلات 3 كجم، وسوائل الجسم 2 كجم، وحجم الدم 1.5–2 كجم، والرحم 1 كجم، والمشيمة 600 جم، والجنين 2.5–4 كجم، والثدي 600–1300 جم، والسائل الأمنيوسي 1 كجم.
- **حسب مؤشر كتلة الجسم قبل الحمل:** أقل من 18.5 تزيد 12–18 كجم، و18.5–24.9 تزيد 11.5–16 كجم، و25–29.9 تزيد 7–11.5 كجم، و30 فأكثر تزيد 5–9 كجم.
- **حسب الثلث:** 0.5–1.5 كجم في الأول، و1.5–4 كجم في الثاني، و4–6 كجم في الثالث.

Abdominal Examination (Leopold's Maneuvers)

- **Estimation of GA by fundal height:** (1) **by hands** — distance between the tip of the thumb and tip of the little finger; (2) **by tape** — symphysis fundal height (SFH) from the symphysis pubis to the top of the uterus.
- Source figure of fundal levels marks **12, 18, 24, 30, 36 and 40** weeks (36 highest, 40 drops slightly below it).
- Abdomen is **longer** if lie is longitudinal (**99.5%** of cases); **lower and broad** if transverse. FHR inspected as evidence of fetal life.

TERM	DEFINITION
Fetal lie	Long axis of fetus to long axis of mother: longitudinal, transverse or oblique
Fetal attitude	Relation of fetal head to trunk: flexed, military, extended, hyperextended
Fetal position	Presenting part to the front, back or side of the maternal pelvis
Fetal presentation	Fetal pole presenting at the pelvic inlet: cephalic (head), breech (feet or buttocks), shoulder
Presenting part	Part of the fetus first touched by the examining fingers during pelvic examination
Fetal heart sound	Sonicaid after **20th week**, Doppler after **10th week**; normal **120–160 beats/min**

فحص البطن (مناورات ليوبولد):
- يُقدّر عمر الحمل بارتفاع قاع الرحم باليد (المسافة بين طرف الإبهام وطرف الخنصر) أو بالشريط من عظم العانة إلى قمة الرحم.
- يكون البطن أطول إذا كان وضع الجنين طوليًا (99.5% من الحالات)، وأقصر وأعرض إذا كان مستعرضًا.
- **الوضع (Lie):** علاقة محور الجنين بمحور الأم؛ **والهيئة (Attitude):** علاقة الرأس بالجذع؛ **والموقع (Position):** علاقة الجزء المتقدم بجوانب حوض الأم؛ **والمجيء (Presentation):** رأسي أو مقعدي أو كتفي.
- يُسمع نبض الجنين بالسونيكيد بعد الأسبوع 20 وبالدوبلر بعد الأسبوع 10، والمعدل الطبيعي 120–160 نبضة في الدقيقة.

Laboratory Examinations, Sonography & Subsequent Visits

LABORATORY EXAMINATIONS

- Blood group and Rh factor
- Hb and Hct → anemia
- Urine analysis → infection or renal disease
- Glucose → screen for gestational diabetes
- In certain cases: antiphospholipid antibodies (abnormal clotting, recurrent miscarriage, antiphospholipid syndrome, autoimmune diseases)

TORCH INFECTION

- **T** — Toxoplasmosis
- **O** — Other (hepatitis A & group B streptococcus)
- **R** — Rubella
- **C** — Cytomegalovirus
- **H** — Herpes genitalis

SONOGRAPHY — USED TO

- Estimate gestational age
- Check amniotic fluid volume
- Check placental position
- Detect multifetal pregnancy
- Determine position of the baby

SUBSEQUENT (ONGOING) VISITS

- Measure fundal height
- FHS, BP, weight and fetal movement
- Vital signs; ask about complaints (nausea, vomiting, headache, urinary complaints, edema, backache, heartburn, constipation)
- Screening: CBC; urine for glucose or proteinuria

التحاليل والموجات فوق الصوتية والزيارات اللاحقة:

- **التحاليل:** فصيلة الدم وعامل ريسس، والهيموجلوبين والهيماتوكريت للأنيميا، وتحليل البول للعدوى وأمراض الكلى، والسكر لاكتشاف سكري الحمل، وأجسام مضادات الفوسفوليبيد في حالات الإجهاض المتكرر أو التجلط.
- **عدوى (TORCH):** داء المقوسات، وأخرى (التهاب الكبد أ والمكورات العقدية ب)، والحصبة الألمانية، والفيروس المضخم للخلايا، والهربس التناسلي.
- **الموجات فوق الصوتية:** لتقدير عمر الحمل، وكمية السائل الأمنيوسي، وموضع المشيمة، والحمل المتعدد، ووضع الجنين.
- **الزيارات اللاحقة:** قياس ارتفاع الرحم، ونبض الجنين، والضغط، والوزن، وحركة الجنين، والسؤال عن الشكاوى، وصورة الدم وتحليل البول للسكر والزلال.

New Model for ANC by WHO — Focused Antenatal Care (FANC)

WHO recommends **4 ANC visits** for low-risk women; frequency increases for high-risk pregnancy according to the woman's condition.

VISIT	TIMING	PURPOSE
1st (1st trimester)	**8–12 weeks**	Confirm pregnancy and EDD; classify women for basic ANC (4 visits) or specialized care
2nd (2nd trimester)	**24–26 weeks**	Maternal and fetal well-being; exclude PIH and anemia; preventive measures; review birth & emergency plan; advice and counsel
3rd (3rd trimester)	**32 weeks**	Same as 2nd + exclude **multiple pregnancies**
4th (3rd trimester)	**36–38 weeks**	Maternal and fetal well-being; exclude **malpresentation**

النموذج الجديد لمنظمة الصحة العالمية (رعاية الحمل المركّزة):

- أربع زيارات للحوامل منخفضات الخطورة، وتزيد للحوامل عاليات الخطورة حسب الحالة.
- **الأولى (8–12 أسبوعًا):** تأكيد الحمل وموعد الولادة وتصنيف المرأة للرعاية الأساسية أو المتخصصة.
- **الثانية (24–26 أسبوعًا):** تقييم الأم والجنين واستبعاد ارتفاع الضغط المرتبط بالحمل والأنيميا، والإجراءات الوقائية، ومراجعة خطة الولادة والطوارئ، والنصح.
- **الثالثة (32 أسبوعًا):** مثل الثانية مع استبعاد الحمل المتعدد.
- **الرابعة (36–38 أسبوعًا):** تقييم الأم والجنين واستبعاد المجيء غير الطبيعي.

Teaching Advice for Pregnant Women

TOPIC	ADVICE
1. Exercise	Simple; walking ideal but avoid long walks; avoid lifting heavy weights (mattresses, furniture → may lead to abortion); avoid long standing (varicose veins); avoid sitting with crossed legs (impedes circulation)
2. Sleep & rest	At least **8 hours** nightly; avoid supine position (**supine hypotension syndrome**)
3. Breasts	Daily washing with clean tap water (**no soap** — drying); glycerin to reduce cracking; firm supportive bra with wide straps; **no breast massage** (may stimulate oxytocin → contractions)
4. Bowel habit	Avoid constipation (straining → piles, genital prolapse): fresh vegetables, milk, pelvic floor exercise, ↑ fluids
5. Clothes	Loose and comfortable; avoid tight breast support; easily fitting, low-heeled shoes

TOPIC	ADVICE
6. Teeth	Regular cleaning at least morning and night
7. Sexual intercourse	Safe throughout pregnancy unless advised otherwise; **avoid completely** with threatened abortion or previous preterm labor
8. Diet	Balanced protein; carbohydrates and fats not in excess; **vitamins C and K** reduce abortion and ante/postpartum hemorrhage; sufficient fluids; **Ca, iron and folic acid** supplementation
10. Travelling	Air travel not harmful without complications; safe up to **36 weeks** with periodic lower-limb movement; **prevent completely** with habitual abortion or premature labor history
11. Immunization	**Tetanus toxoid** for all pregnant women, any time; WHO: as early as possible in the 3rd trimester (**27–36 weeks**); if missed, give immediately postpartum. Avoid contact with rubella. **No live vaccines** (oral Sabin polio, measles, mumps, rubella)

📌 **Note on the source:** The advice list in the source jumps from item 8 (Diet) to item 10 (Travelling); there is no item 9.

نصائح للحامل:

- **الرياضة:** المشي مثالي دون إطالة، وتجنب حمل الأثقال لأنه قد يسبب الإجهاض، وتجنب الوقوف الطويل (الدوالي) ووضع الساق على الساق (يعيق الدورة الدموية).
- **النوم:** 8 ساعات على الأقل، وتجنب الاستلقاء على الظهر لتفادي متلازمة هبوط الضغط الاستلقائي.
- **الثدي:** غسله يوميًا بماء الصنبور دون صابون، والجلسرين لمنع التشقق، وحمالة صدر داعمة بأحزمة عريضة، وعدم تدليكه لأنه قد يحفز الأوكسيتوسين والانقباضات.
- **الإخراج:** تجنب الإمساك لأن الحزق يسبب البواسير وهبوط الأعضاء التناسلية، بالخضروات واللبن وتمارين قاع الحوض والسوائل.
- **الملابس والأسنان:** ملابس واسعة مريحة وحذاء بكعب منخفض، وتنظيف الأسنان صباحًا ومساءً.
- **العلاقة الزوجية:** آمنة طوال الحمل إلا في حالة الإجهاض المهدد أو تاريخ الولادة المبكرة.
- **الغذاء:** بروتين متوازن دون إفراط في النشويات والدهون، وفيتامين ج وك يقللان الإجهاض والنزيف، والكالسيوم والحديد وحمض الفوليك.
- **السفر:** الطيران آمن حتى الأسبوع 36 مع تحريك الساقين، ويمنع مع تاريخ الإجهاض المتكرر أو الولادة المبكرة.
- **التطعيم:** لقاح التيتانوس لكل الحوامل ويفضل بين الأسبوع 27 و36، وإن فات يعطى بعد الولادة مباشرة، وتجنب مخالطة مرضى الحصبة الألمانية، ومنع اللقاحات الحية (شلل الأطفال الفموي، والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية).

Quick Revision — High-Yield Master Table

TOPIC	HIGH-YIELD FACTS & NUMBERS
Viability & parity	Viability ≈ 24 weeks; parity counts deliveries, not fetuses (twins = 1); grand multipara ≥ 5.
Traditional visits	Low-risk: monthly to 28 wk → 2-weekly to 36 wk → weekly. High-risk: 2-weekly to 28 → weekly to 36 → hospitalization.
WHO FANC	4 visits: 8–12 · 24–26 · 32 · 36–38 weeks.
Naegele's rule	LMP + 7 days − 3 months + 1 year (LMP 14/6/2024 → EDD 21/3/2025).
Weight gain	BMI < 18.5: 12–18 · 18.5–24.9: 11.5–16 · 25–29.9: 7–11.5 · ≥ 30: 5–9 kg. Trimesters: 0.5–1.5 / 1.5–4 / 4–6 kg. Baby 2.5–4 kg; placenta 600 g.
Fetal heart	Doppler after 10 wk; Sonicaid after 20 wk; 120–160 bpm. Longitudinal lie 99.5%.
History hazards	Smoking → IUGR; alcohol → IUGR + malformations; heart valve disease → cardiac failure; HTN → pre-eclampsia.
Labs	Blood group/Rh, Hb/Hct, urine, glucose, antiphospholipid (selected), TORCH.
Warning signs	Bleeding, abdominal pain, severe headache, gush of fluid, stopped fetal movement, persistent vomiting, severe edema, fever/dysuria.
Advice	Sleep ≥ 8 h, no supine; no soap or massage of breasts; fly up to 36 wk; tetanus toxoid 27–36 wk; no live vaccines.

مراجعة سريعة:

- سن الحياة 24 أسبوعًا، والتوائم ولادة واحدة، وكثيرة الولادة خمس ولادات فأكثر.
- النموذج التقليدي شهريًا حتى 28 ثم كل أسبوعين حتى 36 ثم أسبوعيًا، ونموذج المنظمة أربع زيارات في الأسابيع 8–12 و24–26 و32 و36–38.
- قاعدة نيجل: + 7 أيام − 3 أشهر + سنة.
- نبض الجنين الطبيعي 120–160، ويُسمع بالدوبلر بعد الأسبوع 10.
- لقاح التيتانوس بين الأسبوع 27 و36، ولا لقاحات حية أثناء الحمل.

Student Self-Evaluation

ℹ️ **ملاحظة:** These are the **original self-evaluation questions** from the source, reproduced as written. The source gives **no answer key**, so the marked answers are worked out from the lecture content.

1 **Mrs. N, in her first antenatal visit, reported that her last delivery was 3 years ago of 2 children born before 37 weeks gestation, and she had one abortion. How do you interpret this?**

- ○ a) Gravida 1, Para 1, 1102
- ○ **b) Gravida 3, Para 1, 0112** ✓
- ○ c) Gravida 2, Para 1, 0112
- ○ d) Gravida 3, Para 2, 1012

الإجابة: b — الحمل الحالي + ولادة واحدة لتوأم + إجهاض = 3 مرات حمل، والتوأم ولادة واحدة فالولادات = 1؛ وTPAL: صفر مكتمل، وواحد مبكر، وإجهاض واحد، وطفلان أحياء = 0112.

2 **The nurse is measuring the fundal height at the 28th week of gestation. The fundal level is expected to be:**

- ○ a) At the umbilicus
- ○ b) At the xiphoid process
- ○ **c) Midway between the umbilicus and the xiphoid process** ✓
- ○ d) Midway between the symphysis pubis and the umbilicus

الإجابة: c — حسب شكل مستويات قاع الرحم في المحاضرة يقع الأسبوع 24 عند السرة تقريبًا والأسبوع 36 عند الناتئ الرهابي، فيكون الأسبوع 28 بينهما.

3 **According to the focused new model of antenatal follow-up, the woman should attend the third visit:**

- ○ a) At 8–12 weeks of gestation
- ○ b) At 24–26 weeks of gestation
- ○ **c) At 32 weeks of gestation** ✓
- ○ d) At 36–38 weeks of gestation

الإجابة: c — في نموذج المنظمة تكون الزيارة الثالثة في الأسبوع 32.

4 **The nurse assessed a woman at 32 weeks of gestation in the prenatal clinic and found the following abnormal feature:**

- ○ a) Heartburn
- ○ b) Ankle edema
- ○ c) Leg cramps
- ○ **d) Slight vaginal bleeding** ✓

الإجابة: d — النزيف المهبلي من علامات الخطر، أما حرقة المعدة وتورم الكاحل البسيط وتقلصات الساق فشكاوى شائعة.

5 **The diet that is appropriate in normal pregnancy should be high in:**

- ○ **a) Protein, minerals, and vitamins** ✓
- ○ b) Carbohydrates and vitamins
- ○ c) Proteins, carbohydrates, and fats
- ○ d) Fats and minerals

الإجابة: a — توصي المحاضرة ببروتين متوازن وفيتامينات (ج وك) ومعادن (كالسيوم وحديد) مع عدم الإفراط في النشويات والدهون.

Answer Key

Q	ANSWER	KEY CONCEPT
1	b	Twins = 1 parity; TPAL 0112
2	c	28 wk between umbilicus and xiphoid (from fundal-height figure)
3	c	FANC 3rd visit = 32 wk
4	d	Vaginal bleeding = warning sign
5	a	Protein, minerals, vitamins

مفتاح الإجابات:

- 1 (ب)، 2 (ج)، 3 (ج)، 4 (د)، 5 (أ).
- **تنبيه:** الأسئلة أصلية من المحاضرة، لكن المصدر لا يحتوي على مفتاح إجابات، والإجابات مستنتجة من محتوى المحاضرة.

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختامًا: نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين